# TEMA 33 · Planificación familiar. Métodos anticonceptivos. Embarazos no deseados. Prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Intervenciones de enfermería

Resumen OPE Enfermería SMS · PIAM y Ley Orgánica 1/2023, índice de Pearl y criterios de la OMS, anticoncepción hormonal combinada y olvidos, solo gestágeno e implante, DIU, barrera, MELA, anticoncepción de urgencia, IVE, ITS, PrEP y PEP, PERSEA, VPH, NANDA-NIC-NOC, métodos naturales, esterilización y programa CERCA

## 1. Planificación familiar y marco legal

- Objetivos: evitar embarazos no planificados, **espaciar** los nacimientos y prevenir las **ITS**, con un modelo de **decisión compartida**, información veraz y **sin juicios**.
- **PIAM (Programa Integral de Atención a la Mujer, SMS)**: mujeres **desde los 14 años**; subprogramas de malestar biopsicosocial, cáncer ginecológico, salud sexual y anticoncepción, embarazo-parto-puerperio, IVE y climaterio. La **comisión de seguimiento de área** la preside el **Gerente de Área**; en cada centro de salud hay un **representante del PIAM** (médico, enfermera o matrona).
- **Multiculturalidad**: competencia cultural. **Latinoamericanas: cribado de Chagas** (el tratamiento está contraindicado en el embarazo); **subsaharianas**: riesgo de **mutilación genital**; **Europa del Este**: tuberculosis y hepatitis B (con tratamiento correcto de la tuberculosis **no se separa al niño ni se suspende la lactancia**); **magrebíes**: preferencia por profesionales mujeres.
- **Ley Orgánica 1/2023**: las chicas de **16 y 17 años** acceden a la **IVE y a la anticoncepción sin consentimiento de sus padres**; se **suprime el periodo de reflexión de 3 días**; la información sobre ayudas a la maternidad se da **solo si se pide**; **baja por menstruación incapacitante**; la esterilización, anticoncepción y aborto **forzosos** son **violencia reproductiva**.

## 2. Consejo anticonceptivo

- **Índice de Pearl**: **embarazos por cada 100 mujeres durante 1 año** de uso (cuanto **menor**, más eficaz). **Eficacia** = uso perfecto; **efectividad** = uso habitual (con errores). Los **LARC (DIU e implante)** apenas tienen diferencia entre ambas: **de primera elección** porque no dependen del cumplimiento; la píldora y el preservativo tienen una gran diferencia.
- **Criterios médicos de elegibilidad de la OMS**: **1** sin restricción; **2** beneficios > riesgos; **3** riesgos > beneficios (solo si no hay alternativa); **4 riesgo inaceptable = contraindicación absoluta**.
- **Categoría 4 para estrógenos**: **≥ 35 años y fumar ≥ 15 cigarrillos/día** (las dos cosas), **migraña con aura** (a cualquier edad), antecedente de **ictus, AIT o trombosis venosa**.

## 3. Métodos anticonceptivos

- **Anticoncepción hormonal combinada** (estrógeno + gestágeno; **píldora, parche, anillo**): **inhibe la ovulación** (bloquea el pico de LH) y espesa el moco. Riesgo principal: **tromboembolismo venoso** (3-4 veces más que en no usuarias); **menor con levonorgestrel** (2.ª generación) y **mayor con desogestrel, gestodeno y drospirenona** (3.ª-4.ª).

| Situación | Actuación |
|---|---|
| **Olvido de 1 píldora** (< 24 h de retraso) | Tomarla **en cuanto se recuerde** (aunque coincidan dos); **no** hace falta protección extra |
| **Olvido de ≥ 2 píldoras** (> 48 h) | Tomar la **última** olvidada y seguir; **preservativo 7 días** |
| Olvidos en la **1.ª semana** con coito en los 5 días previos | Valorar **anticoncepción de urgencia** |
| Olvidos en la **3.ª semana** | Terminar las activas y **empalmar** con el envase siguiente **sin descanso** |

| Situación | Actuación |
|---|---|
| **Anillo fuera < 3 h** | Lavar con agua y reinsertar |
| **Anillo fuera > 3 h (1.ª-2.ª semana)** | Reinsertar + **preservativo 7 días** (en la 3.ª semana, anillo nuevo sin descanso) |
| **Parche despegado < 48 h** | Volver a pegarlo o poner uno nuevo; sin cambios |
| **Parche despegado ≥ 48 h** | Parche nuevo = **nuevo día 1** + **preservativo 7 días** |

- **Solo gestágeno** (minipíldora, **implante**, inyectable trimestral): **espesa el moco** y atrofia el endometrio (el **desogestrel 75 mcg** y el **implante** también **inhiben la ovulación**). Para mujeres con **contraindicación de estrógenos** y en la **lactancia**.
- **Implante de etonogestrel**: varilla subdérmica en la **cara interna del brazo no dominante**; **3 años**; Pearl **≈ 0,05**. La principal causa de retirada son las **alteraciones del sangrado** (≈ 20% amenorrea, ≈ 50% sangrado infrecuente o irregular): **informar antes de ponerlo**.
- **DIU**: **de cobre** (reacción inflamatoria espermicida) y **de levonorgestrel** (atrofia endometrial y moco espeso). **Contraindicados** en embarazo, **enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) activa**, cervicitis purulenta, sepsis puerperal, sangrado no diagnosticado y cáncer de cérvix o endometrio.
- Riesgo de **EIP** en los **primeros 20 días**. Con EIP **no se retira de entrada**: antibióticos y retirar solo si **no mejora en 72 h**.
- Si **no se ven los hilos**: **ecografía**. Embarazo con DIU y hilos visibles: **retirarlo** cuanto antes (antes de la semana 12).
- **Preservativo**: el único con **doble protección** (embarazo e ITS). Con látex, lubricantes **acuosos o de silicona** (los oleosos lo dañan). **Diafragma**: **siempre con espermicida**; se deja **6-8 horas después** del coito y **nunca más de 24 h** (shock tóxico).
- **MELA** (amenorrea de la lactancia; > 98% eficaz) exige **los tres criterios a la vez**: **lactancia exclusiva o casi exclusiva** (sin pausas de **> 4 h de día ni > 6 h de noche**), **amenorrea** y **bebé < 6 meses**. Si falla uno, pasar a un método compatible (gestágeno, implante, DIU).
- **Naturales** (baja efectividad): **Billings** (moco fértil **filante y transparente**, cristaliza **en helecho**); **temperatura basal** (sube **0,2-0,5 °C después** de la ovulación, por la progesterona: **confirma**, no predice); **Ogino-Knaus** (ciclo más corto − 18 y más largo − 11; el menos fiable).
- **Esterilización**: la **vasectomía no es eficaz de inmediato**: usar otro método hasta un **seminograma negativo** (**≈ 3 meses o 20 eyaculaciones**). La **ligadura de trompas** es eficaz desde la intervención.

## 4. Anticoncepción de urgencia

- Actúa **antes de la fecundación**: **retrasa o impide la ovulación**; **no es abortiva** ni teratógena. Se dispensa en farmacias **sin receta**. No es un método habitual.

| Opción | Plazo | Claves |
|---|---|---|
| **Levonorgestrel 1,5 mg (dosis única)** | Hasta **72 h** (mejor en 24 h) | Menos eficaz con **sobrepeso** (> 75 kg o IMC ≥ 26: mejor ulipristal o DIU). Permite **empezar el anticonceptivo habitual en el acto** |
| **Ulipristal 30 mg (modulador de los receptores de progesterona)** | Hasta **120 h (5 días)** | Más eficaz cerca de la ovulación. **Esperar 5 días** para iniciar el método hormonal habitual (preservativo mientras tanto) |
| **DIU de cobre** | **Hasta 5 días** | **El más eficaz**; **no le afecta el peso**; queda como anticonceptivo |

## 5. Embarazo no deseado e IVE

- Atención empática, confidencial y sin juicios (en OMI-AP, código **W33**, episodio **reservado**).

| Supuesto (Ley 2/2010 y LO 1/2023) | Plazo | Requisito |
|---|---|---|
| **A petición de la mujer** | **Hasta la semana 14** | Consentimiento; **sin periodo de reflexión** |

| Supuesto (Ley 2/2010 y LO 1/2023) | Plazo | Requisito |
|---|---|---|
| **Grave riesgo para la vida o salud de la embarazada** | **Hasta la 22** | Dictamen de **un especialista** distinto del que la practica |
| **Graves anomalías fetales** | **Hasta la 22** | Dictamen de **dos especialistas** distintos |
| **Anomalías incompatibles con la vida** o enfermedad fetal extremadamente grave e incurable | **Sin límite** | Dictamen de especialista o confirmación por el **comité clínico** |

- **IVE farmacológica** (hasta la **semana 9**): **mifepristona 200 mg oral** (antiprogestágeno: detiene la gestación) y, a las **24-48 h**, **misoprostol 800 mcg** (prostaglandina: contracciones y expulsión). Dolor con **ibuprofeno**. Control a los **15-21 días**.
- **Tras la IVE**: sangrado y molestias tipo regla unos 15 días; acudir a urgencias si **fiebre > 38 °C**, dolor intenso, flujo maloliente o **hemorragia (> 2 compresas grandes por hora durante 2 horas)**; **anticoncepción inmediata** (la ovulación vuelve en 2-3 semanas); revisión a los 15-20 días.

## 6. Infecciones de transmisión sexual

- **Aumento sostenido** de gonococia, clamidia y **sífilis**, sobre todo en jóvenes.

| ITS | Claves |
|---|---|
| **Clamidia** | **La más frecuente**; **casi siempre asintomática**; principal causa de **EIP e infertilidad tubárica** |
| **Gonorrea** | **Exudado purulento**, disuria; **resistencias** antibióticas crecientes |
| **Sífilis** | **Primaria: chancro duro e indoloro** (el **chancro blando** de *H. ducreyi* duele); **secundaria: exantema en palmas y plantas**; terciaria: neurosífilis y afectación cardiovascular |
| **VPH** | Tipos **6 y 11: verrugas genitales**; tipos de alto riesgo (16, 18…): cáncer de **cérvix**, ano, vulva, vagina, pene y orofaringe |

- **PrEP** (preexposición): antirretrovirales **continuos** en personas **VIH negativas** con alta exposición; controles **trimestrales** de VIH, otras ITS y función renal.
- **PEP** (postexposición): **urgencia**; empezar **lo antes posible** (idealmente en 2 h) y **nunca después de 72 h**; dura **28 días**.
- **Programa PERSEA** (Murcia): educación afectivo-sexual en **2.º de ESO** con el centro de salud: diversidad, consentimiento, mitos del amor romántico, **preservativo** y alcohol/drogas.
- **Vacuna VPH (nonavalente)**: **12 años, chicas y chicos**. Pautas de 3 dosis en grupos de riesgo: VIH, hombres que tienen sexo con hombres, prostitución y **mujeres tratadas por lesión de alto grado (CIN2+) sin límite de edad**.
- Enfermería: consulta confidencial, **estudio de contactos** (evitar el «ping-pong») y **notificación de las EDO**.

## 7. Cuidados (NANDA-NIC-NOC)

- Patrones de Gordon clave: percepción-manejo de la salud, **sexualidad-reproducción** y autopercepción.
- **NANDA**: **Disfunción sexual (00059)** = cambio **fisiológico** limitante (dolor, sequedad); **Patrón sexual ineficaz (00065)** = **preocupación o insatisfacción** con la propia sexualidad; **Riesgo de infección (00004)** = uso irregular del preservativo; gestión ineficaz de la salud familiar.
- **NOC**: control del riesgo de ITS, conocimiento de planificación familiar y de la función sexual, medidos con **escalas tipo Likert (1-5)**.
- **NIC**: **Asesoramiento sexual (5248)** = proceso **interactivo** de ayuda (pactar estrategias, afrontar miedos); **Educación para la salud** = **enseñar** (talleres, poner un preservativo con un modelo, qué hacer ante olvidos); **Vigilancia (6650)** = **monitorizar** (tensión arterial con estrógenos, hilos del DIU, implante, síntomas de ITS).

## 8. Cribado de cáncer de cérvix (programa CERCA, Murcia)

| Edad | Prueba |
|---|---|
| **25-34 años** | **Citología** cada **3 años** |

| Edad | Prueba |
|---|---|
| **35-65 años** | **Test de VPH de alto riesgo** cada **5 años** |

- Antes de los 35 la infección transitoria por VPH es muy frecuente (demasiados falsos positivos). Enfermería capta a las mujeres **nunca cribadas** o con más de 5 años sin control.

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! Pearl = embarazos por **100 mujeres** en **1 año**.
! OMS 4 con estrógenos: **≥ 35 años y ≥ 15 cigarrillos**, **migraña con aura**, ictus o trombosis.
! **1 píldora olvidada: tomarla, sin preservativo; ≥ 2: preservativo 7 días.**
! **Anillo 3 horas**; **parche 48 horas**.
! Implante: se retira sobre todo por **sangrados irregulares**.
! DIU con EIP: **antibióticos** y retirar solo si **no mejora en 72 h**.
! MELA: **< 6 meses + lactancia exclusiva + amenorrea**.
! **Levonorgestrel 72 h; ulipristal y DIU de cobre 5 días; el DIU es el más eficaz.**
! Tras ulipristal, **esperar 5 días** para el anticonceptivo hormonal.
! **IVE a petición hasta la semana 14, sin días de reflexión; 16-17 años sin permiso paterno.**
! Vasectomía: **seminograma negativo** antes de confiar en ella.
! Diafragma: **6-8 h** tras el coito y con espermicida.
! PEP: antes de **72 h** y durante **28 días**.
! CERCA: citología **25-34** (cada 3 años) y **VPH 35-65** (cada 5).